	FORMATO PLANTILLA DE ACTA	CÓDIGO:
	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	GC-C-F-003
	PROCESO: CALIDAD	VERSIÓN:
	SUBPROCESO: CONTROL DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	V02-2025

Planeación

Fecha

Martes, 21 de Julio de 2026 / 09:36 AM - 10:45 AM

Lugar

HOSPITALIZACION PRIMER PISO SERVICIO DE GINECOLOGI

Asistentes

Nombre	Cargo	Área/Empresa	Asistió
Sharon Katherine Acuña Rubiano	LÍDER DE GINECOOBSTETRICIA	Hospitalización	No
Katherin Yuliana Camargo Zambrano	MEDICO ESPECIALISTA-GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	Unidades Funcionales	No
Karen Camila Duarte Duarte	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Unidades Funcionales	No
Karen Mayeissy Gomez Gomez	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Unidades Funcionales	No
Karen Julieth Garzón Yepes	AUXILIAR DEL ÁREA DE LA SALUD HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización	No

Tema de Reunión / Equipo Primario

SIMULACRO TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO

Desarrollo

Contenido

ORDEN DEL DÍA

---

se realiza simulacro en el primer piso de ginecologia hospitalizacion puerperio con una paciente hospitalizada , a quien se le toma la tension arterial con una tension de 170/110

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

---

se realiza simulacro en el primer piso de ginecologia hospitalizacion puerperio con una paciente hospitalizada , a quien se le toma la tension arterial con una tension de 170/110 , esta tension es tomada por la auxiliar de enfermeria quien activa equipo de respuesta rapida obstetrica realizan el siguente manejo

- sv iniciales TA 170/110 FC 88 FR 18 T 36.3 SAT 98% T 36 hora de activacion : 9-36

- Se realiza llamado telefonico al servicio de ginecologia segundo piso , se comenta la paciente con indicacion de asistencia de equipo de respuesta rapida obstetrica.

- llegada del ginecologo al menos de un minuto desde la activacion 9+ 37

Vista Previa

. canalizar dos venas 9+37

- revision de la paciente toma de nuevos signos vitales

- admiistracion de nifedipino 9+42 dosis 30 mg

- labetalol 20 mg 9+43 am

- impregnacion sulfato de magnesio 9-43 + sonda vesical

- laboratorio llega a las 9-46

. tercera auxilar llega a los 7 minutos de la activacion del equipo

- inio de manetimiento con sulfato de magnesio 9-47

. medico baja alos 6 minutos de la activacion

- se realiza toma de tension arterial cada. 5 munutos con verificacion de lista de chequeo estrategia isabel

- terapia respiratoria llega a los 12 minutos

- se verigica a los. 20. minutos tension en 140/90 y finaliza simulacro

se realiza analisis con el equipo con los siguientes puntos positivos

- se activa el equipo de respuesta rapida

- llega rapidamente la jefel del servicio y la ginecologa para la atencion de la paciente

- se realiza el manejo segun estrategia isabel

puntos negativos ***

se informo inicialmente con el normbre de la paciente que no correspondia lo que creo confusion incial en la activacion

se entrol incompleto el kit de codigo rojo sin la sonda vesical

los tiemps de respuesta de los diferentes servios demoro mas por que no fue clara la indicacion de activacion en primer piso o segundo piso de ginecologia

planes de mejora

- se indica a la auxiliar que esta en hospitalizacion ginecologia que al activar el equipo de respuesta rapida debe inmediatamente canalizar dos venas de la paciente y monitorizar la paciente , asi como buscar el kit de emergencia obstetrica mientras llega el personal del segundo piso .

- colocar un timbre para activacion del equipo en hospitalizacion ginecologia , accion realizada inmediatamente

-entrenar a un segundo medico de hospitalizacion para que responda al llamado hasta que llegue el ginecologo o medico del segundo piso ginecologia

- tener una camilla de traslado para las paceintes que se deban llevar a salas de cirugia

Vista Previa

Compromisos

- entrenar a un segundo medico de hospitalizacion para que responda al llamado de la emergencia obstetrica. hasta que llegue el ginecologo o medico del segundo piso ginecologia

entrenar a un segundo medico de hospitalizacion para que responda al llamado hasta que llegue el ginecologo o medico del segundo piso ginecologia

Responsables: Sharon Katherine Acuña Rubiano

Fecha límite: 2026-07-21

Vista Previa